SDD 318 Sujet n°1

Spécialité : Pédiatrie

Date : novembre 2024
Auteur : Marie-Lise PAJCZER (DES Pédiatrie Nantes, ECN 2023), Olivia Humez (DES Pédiatrie Paris, ED 2024)
Relecteur(s) : Sébastien VILLARD (DES de Médecine interne Paris, ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Education/prévention
Domaine d'apprentissage secondaire	Entretien/interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	345. Malaise grave du nourrisson et mort inattendue du nourrisson
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 318
Matériel nécessaire à la station	Photo, table, chaise
Contexte de la station	Consultation chez le médecin généraliste Conseil de prévention MIN

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes remplaçant en cabinet de médecine générale et vous recevez le jeune Titouan, 9 jours, pour sa consultation obligatoire. Sa maman vous montre des photos de son retour à la maison et notamment une photo de la chambre de son bébé qu'elle est très fière d'avoir aménagée.

Dans le dossier informatisé de Titouan, vous découvrez que ses parents ont déjà perdu un bébé vers ses 6 mois de vie, sans qu'une cause claire n'ait été retrouvée.

Consignes :

Vous devez en 8 minutes :

- *Réaliser un interrogatoire à la recherche de facteurs de risque de mort inattendue du nourrisson*
- *Communiquez à la maman des consignes simples de prévention de la mort inattendue du nourrisson*

Vous disposez de la photographie de la chambre de Titouan à l'intérieur de la station.

Vous ne devez pas :

- *Examiner l'enfant*
- *Proposer d'examen complémentaire*
- *Poser de diagnostic concernant l'aîné décédé*

Il s'agit d'une station avec parent standardisé.

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	Recherche d'antécédents à risque (a minima 2) : Prématurité, RCIU, Tabagisme anténatal, Sexe masculin, Troubles du rythme cardiaque connus, malformations connues, maladies métaboliques héréditaires	1 point	☐
2.	Recherche d'un contexte à risque : mère jeune OU grossesse non suivie OU milieu défavorisé	1 point	☐
3.	Recherche un tabagisme parental OU encourage le sevrage tabagique	1 point	☐
4.	Recherche un allaitement maternel OU propose un allaitement maternel	1 point	☐
5.	Recherche un antécédent de mort subite du nourrisson	1 point	☐
6.	Identifie comme erreur dans la chambre de Titouan : le couchage avec couverture OU doudou OU oreiller	1 point	☐
7.	Corrige l'erreur de couchage : matelas ferme sans oreiller, ni couette, ni rien dans le lit	1 point	☐
8.	Préconise un couchage en décubitus dorsal	1 point	☐
9.	Identifie comme erreur dans la chambre de Titouan : le fait qu'il dorme seul	1 point	☐
10.	Corrige en expliquant qu'il faut privilégier un berceau dans la chambre des parents au moins jusqu'à 6 mois ET ne doit pas être en co-spleeping	1 point	☐
11.	Préconise les règles de température optimale pour le sommeil du nourrisson : ne pas surcouvrir l'enfant ET une chambre à 18-20°	1 point	☐
12.	Expose à la maman que les consignes sont rappelées dans le carnet de santé	1 point	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Communications et attitudes

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

TOTAL	/16 points

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Éléments de rétroaction :

La prévention tient une place centrale en pédiatrie ++ donc ce genre de stations est plutôt tombable ++.

Ne pas oublier que vous vous adressez ici à un parent stressé, qui souhaite bien faire mais n'a pas forcément les clefs pour réussir : c'est à vous de les donner de façon didactique et encourageante. Et surtout agissez toujours avec empathie !

Quelques éléments de cours (source : collège de Pédiatrie)

Environ 350 à 400 décès par an chez l'enfant de moins de 1 an. La mort subite du nourrisson touche 150 à 200 enfants par an (0,2 à 0,3‰ des naissances vivantes, soit 6% de la mortalité infantile)
Pic de survenue entre 2 et 4 mois

Facteurs de risques connus

- Antécédents : prématurité, sexe masculin, tabagisme parental
- Age < 6 mois, période hivernale
- Couchage en décubitus ventral, lieu surchauffé
- Co-sleeping
- Jouet, couverture, doudou, tour de lit, oreiller, etc présent dans le lit
- Mère jeune, milieu défavorisé

Etiologies parfois retrouvées

- Infections respiratoires (bronchiolite, coqueluche, etc)
- Infections virales ou bactériennes graves (méningite, encéphalite, myocardite, sepsis)
- Déshydratation
- Accident domestique (strangulation, inhalation de corps étranger, etc)
- Maltraitance
- Rares : troubles du rythme cardiaque, malformation cardiaque, maladie métabolique, etc

Les **mesures préventives** doivent être connues de tous les parents (ils sont rappelés dans le carnet de santé).

- Couchage en décubitus dorsal
- Pas de co-sleeping
- Berceau dans la chambre des parents au moins jusqu'à 6 mois
- Matelas ferme sans oreiller ni couette ni cocon ni tour de lit ni couverture
- Ne pas surcouvrir l'enfant
- Chambre à 18-20°
- Proscrire le tabagisme familial
- Encourager l'allaitement maternel

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

PHOTOGRAPHIE DISPONIBLE DANS LA STATION

Photographie posée le parent standardisé, face découverte mais l'étudiant doit demander à la voir pour s'appuyer dessus pour son exposé.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes remplaçant en cabinet de médecine générale et vous recevez le jeune Titouan, 9 jours, pour sa consultation obligatoire. Sa maman vous montre des photos de son retour à la maison et notamment une photo de la chambre de son bébé qu'elle est très fière d'avoir aménagée.

Dans le dossier informatisé de Titouan, vous découvrez que ses parents ont déjà perdu un bébé vers ses 6 mois de vie, sans qu'une cause claire n'ait été retrouvée.

Plan de la station ECOS :

Entretien chez le médecin généraliste.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Bonjour docteur,
Je suis très heureuse de vous présenter Titouan ! Depuis le temps que je l'attendais. Il a 9 jours de vie et se porte « comme un charme ».
Regardez, je vous ai amené quelques photos de son retour à la maison !

Identité du patient :

Titouan, 9 jours de vie

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Mode de vie :

2ème enfant du couple.
L'ainée, Héloïse, est décédée dans son sommeil à l'âge de 6 mois sans qu'aucune cause retrouvée.

Maman 29 ans, décoratrice d'intérieure
Papa 32 ans, journaliste fume 2 cigarettes par jour quand il est stressé

Pas d'allergie dans la famille

Allaitement artificiel (hypolactation de la maman dès la maternité)

Comportement global :

Mère inquiète, très rationnelle
S'est beaucoup renseignée dans des livres, sur internet, auprès de ses copines qui ont déjà plusieurs enfants
Se triture les mains sous la table dès qu'on aborde le sujet d'Héloïse

Antécédents personnels :

Grossesse sans particularité, échographies anténatales normales

Accouchement voie basse à 39+6 SA sous péridurale
Bonne adaptation à la vie extra-utérine.
Parcours simple en maternité, pas d'ictère, pas d'hypoglycémie
Immunoprophylaxie par Beyfortus réalisée à la maternité
Retour à domicile à J3 de vie

Pas d'allergie connue

Antécédents familiaux :

Asthme chez le papa

Médicaments :

Zyma D 2 gouttes par jour
Vitamine K1 1 ampoule à 1 mois de vie

Symptômes positifs :

/

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Constantes :

/

Donnée complémentaire :

Photo de la chambre de Titouan lors du retour à domicile (il y a 5 jours)

Questions de relance :

« Et vous pensez que si je lui donnais mon lait, il y aurait moins de risque ? »

- à énoncer à la 6e minute si non abordé auparavant

Si n'utilise pas la photo au bout de 5 minutes :
« D'ailleurs docteur, est ce que vous pourriez me montrer ce qui ne convient pas dans la chambre de Titouan ? »

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)